Pathologies du tube digestif

Les figures du cours à savoir refaire : cache-les, redessine-les, compare.

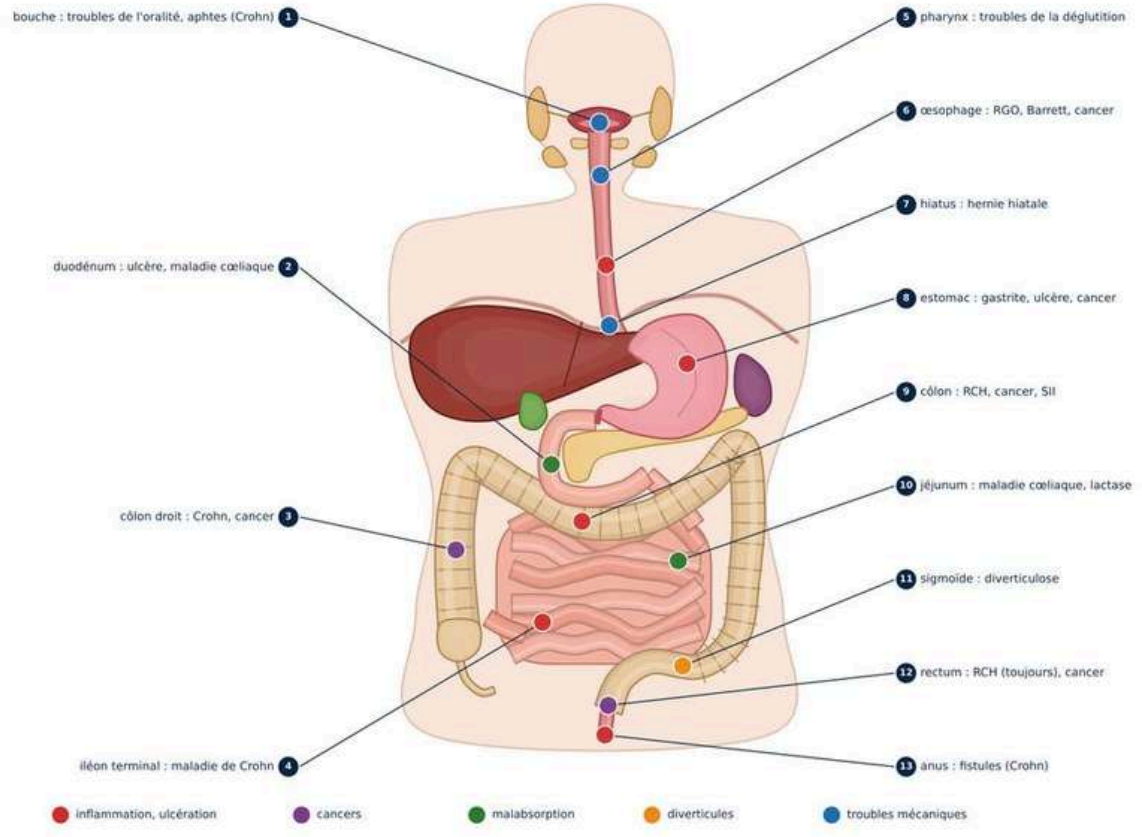


Planche – sites des principales pathologies du tube digestif (vue de face ; la droite du sujet est à gauche de l'image)

Figure 32.1 – Les principales pathologies du tube digestif, organe par organe, classées par type (inflammation, cancer, malabsorption, diverticules, troubles mécaniques) (32.3)

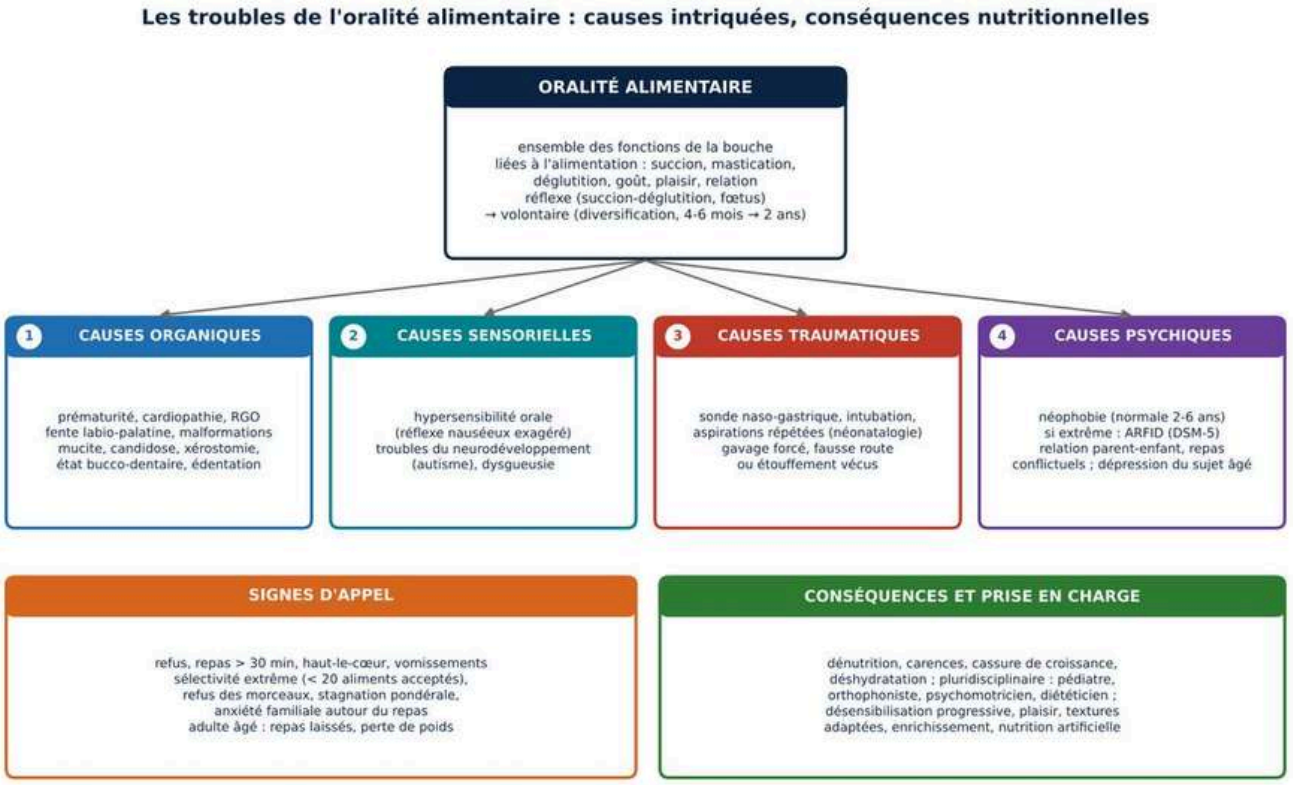


Figure 32.2 – Les troubles de l'oralité alimentaire : quatre familles de causes intriquées, signes d'appel, conséquences et prise en charge (32.3.1)

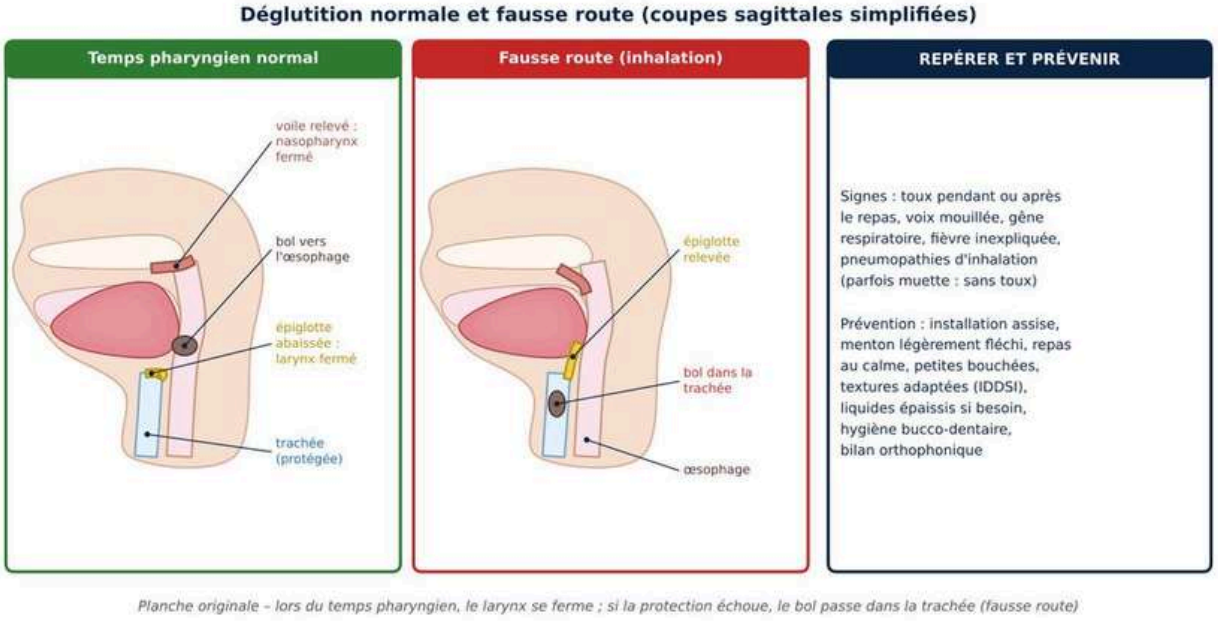


Planche originale – lors du temps pharyngien, le larynx se ferme ; si la protection échoue, le bol passe dans la trachée (fausse route)

Figure 32.3 – Déglutition normale et fausse route : coupes sagittales simplifiées du carrefour aérodigestif (32.3.2)

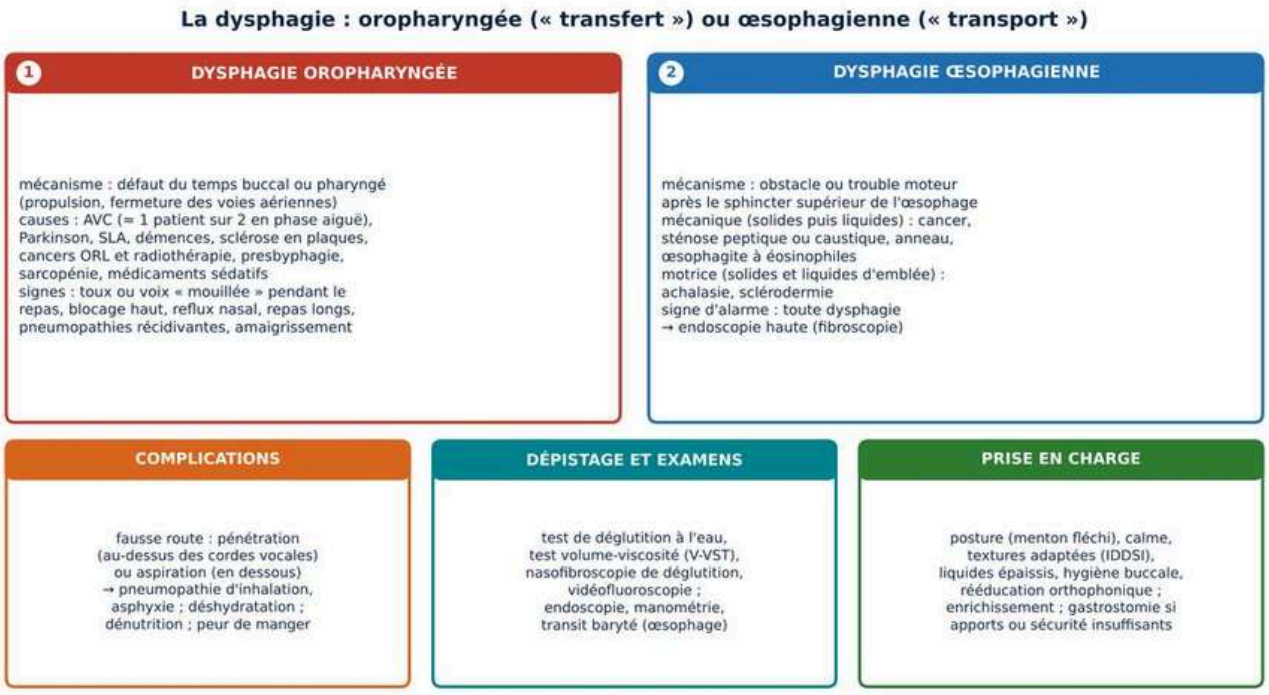


Figure 32.4 – La dysphagie : oropharyngée (trouble du transfert) ou œsophagienne (trouble du transport) ; complications, dépistage et prise en charge (32.3.2)

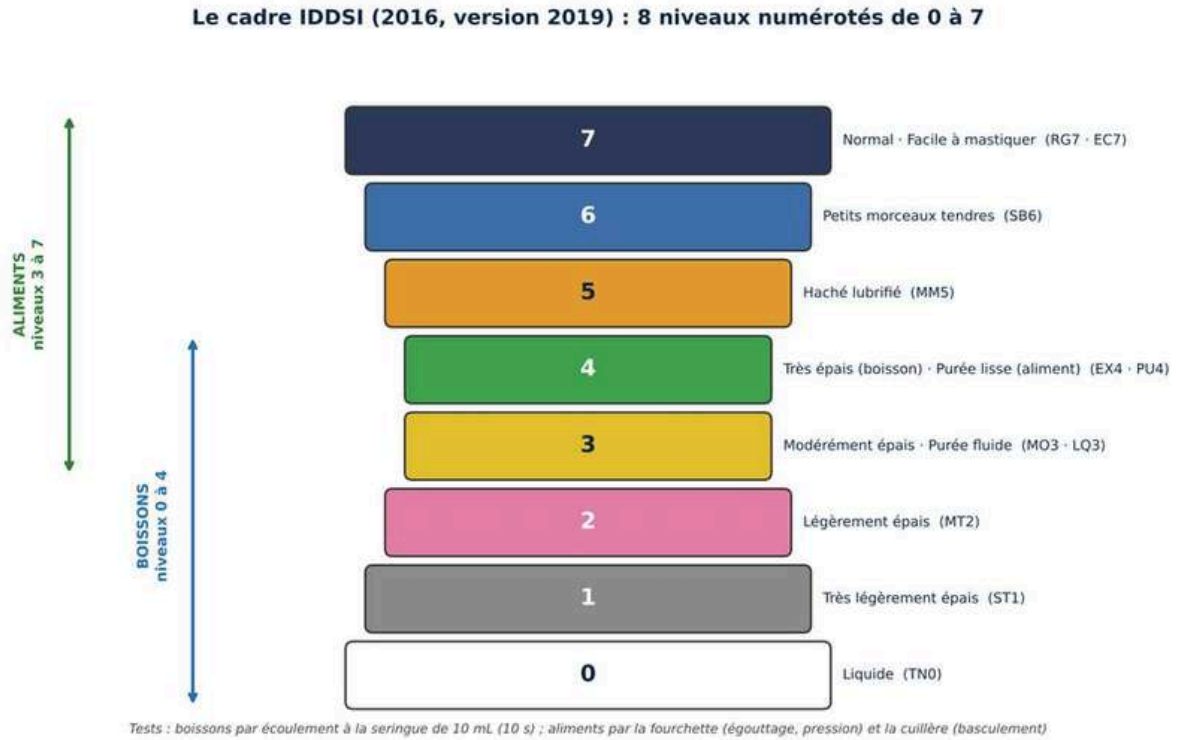


Figure 32.5 – Le cadre IDDSI : 8 niveaux de 0 à 7 ; les boissons utilisent les niveaux 0 à 4, les aliments les niveaux 3 à 7 (32.3.2)

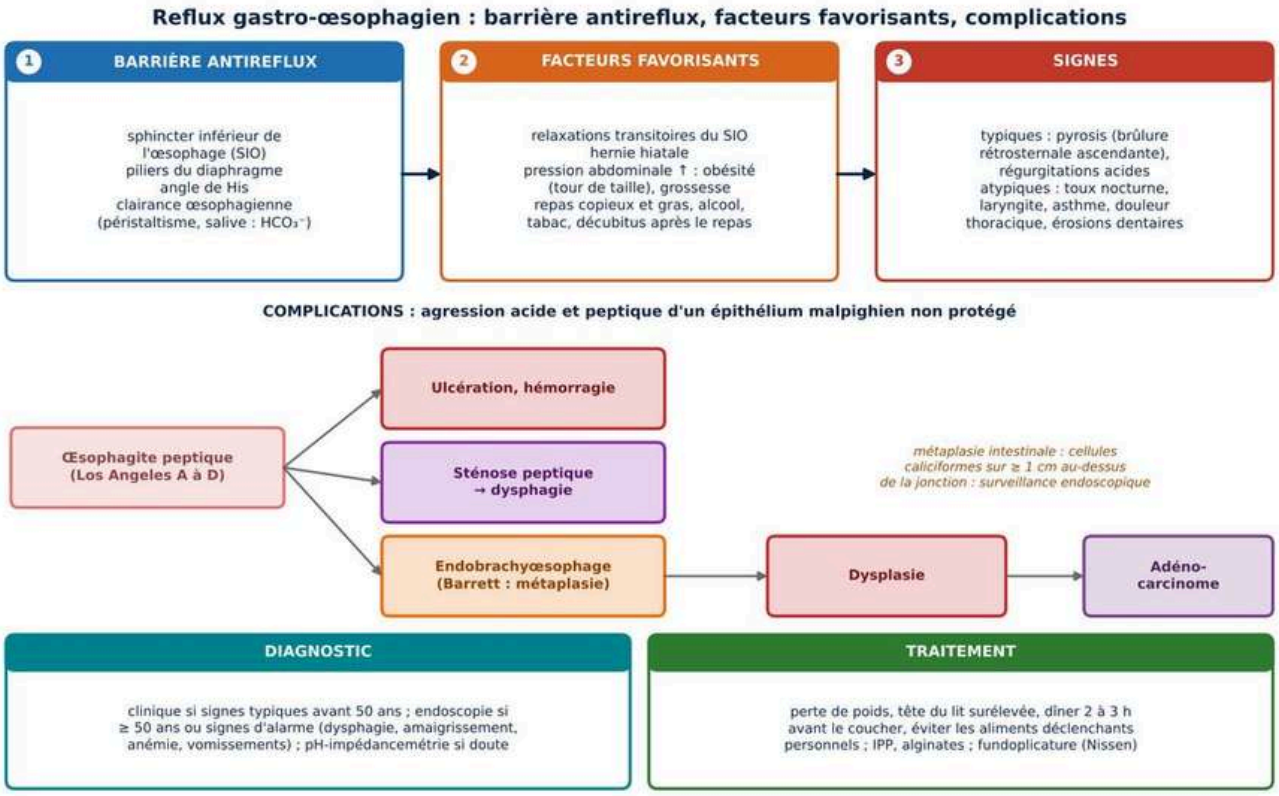


Figure 32.6 – Le reflux gastro-œsophagien : barrière antireflux, facteurs favorisants, signes, complications, diagnostic et traitement (32.3.3)

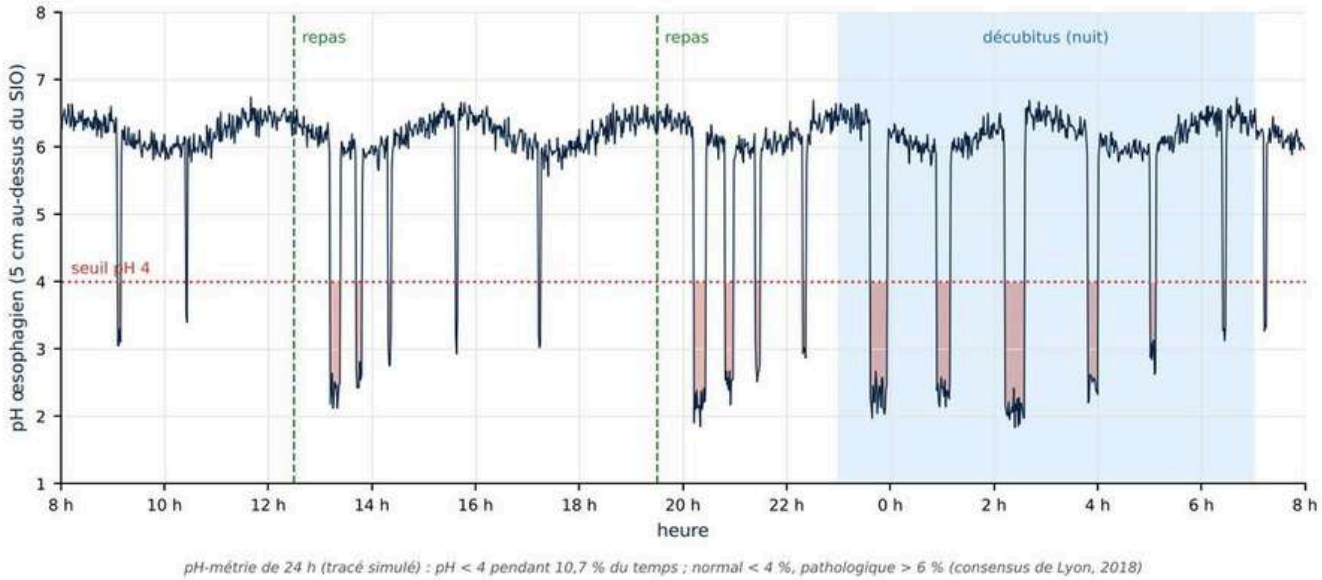


Figure 32.7 – pH-métrie œsophagienne de 24 heures (tracé simulé) : les chutes du pH sous 4 sont des épisodes de reflux acide (32.3.3)

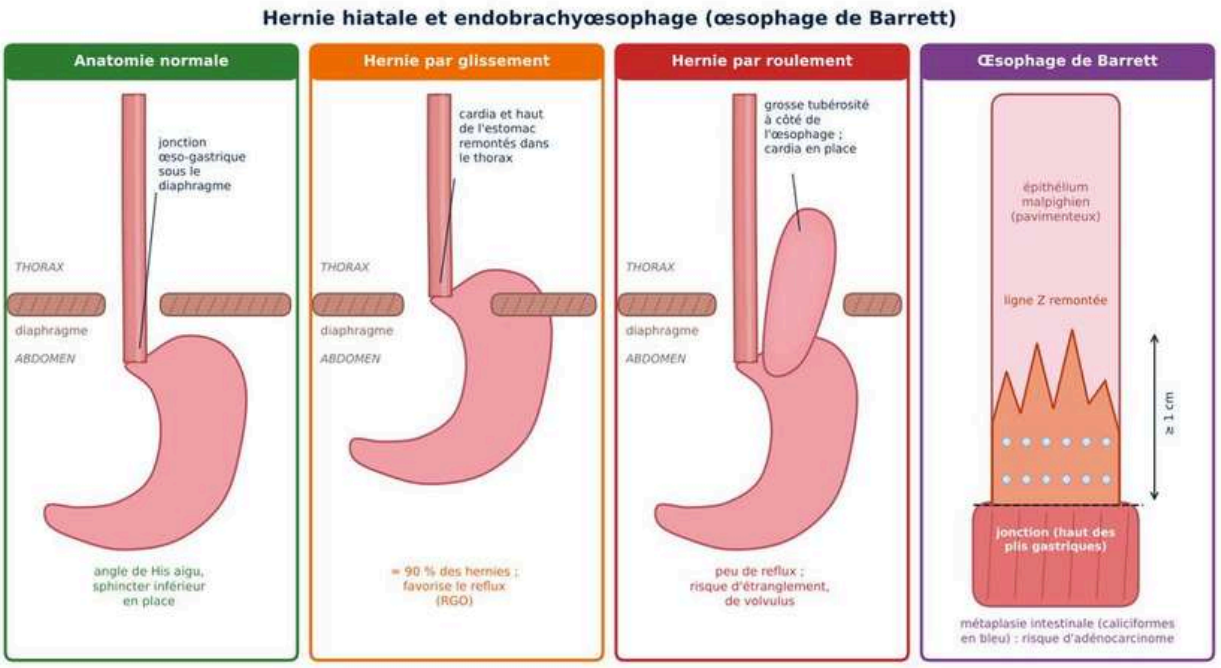


Planche originale – vue de face schématique ; à droite, œsophage ouvert : la muqueuse glandulaire remonte au-dessus de la jonction

Figure 32.8 – Anatomie normale, hernie hiatale par glissement et par roulement, endobrachyœsophage (œsophage de Barrett) (32.3.3)

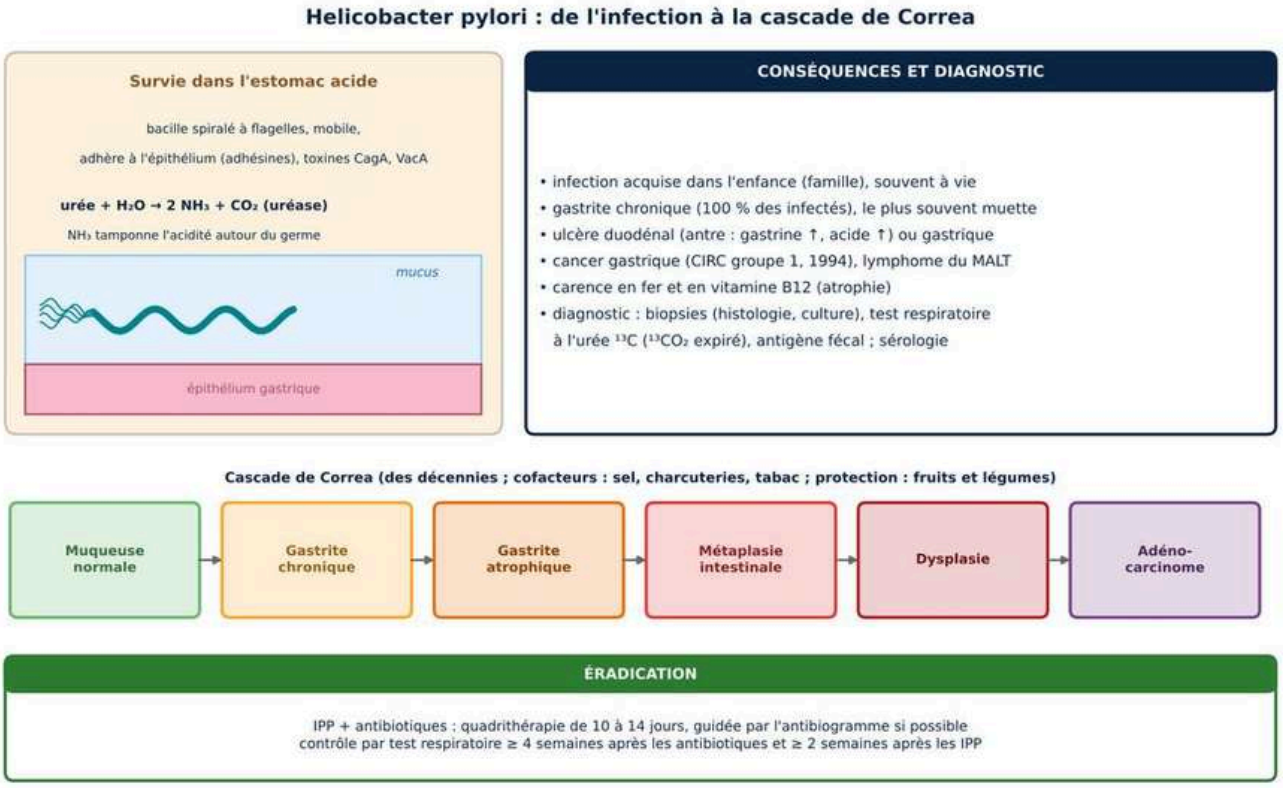


Figure 32.9 – Helicobacter pylori : survie dans l'estomac acide, conséquences, diagnostic, cascade de Correa et éradication (32.3.3)

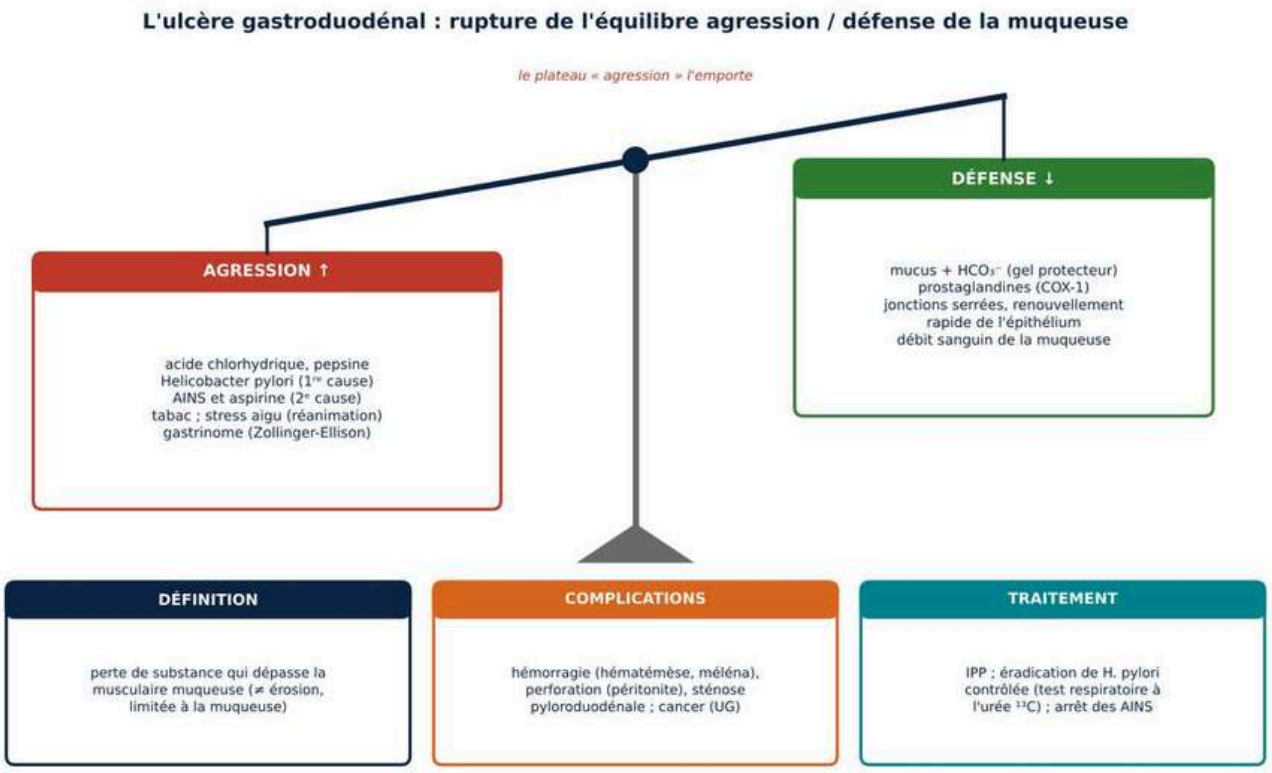


Figure 32.10 – L'ulcère gastroduodénal : rupture de l'équilibre entre agression et défense de la muqueuse (32.3.3)

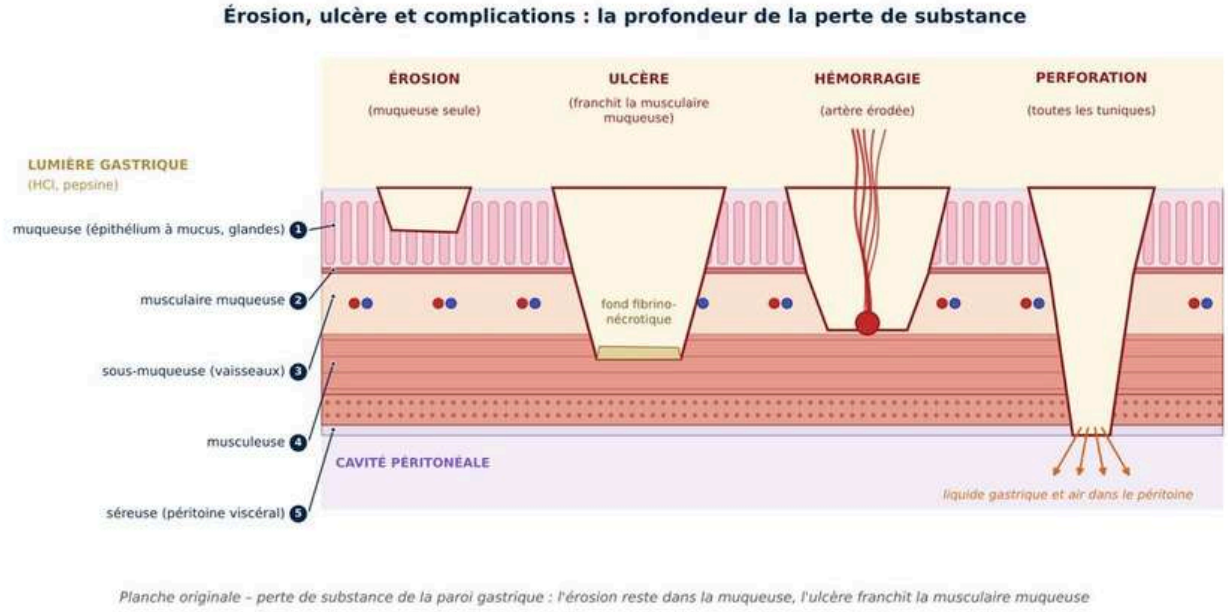


Planche originale – perte de substance de la paroi gastrique : l'érosion reste dans la muqueuse, l'ulcère franchit la musculaire muqueuse

Figure 32.11 – Érosion, ulcère, hémorragie et perforation : la profondeur de la perte de substance dans la paroi gastrique (32.3.3)

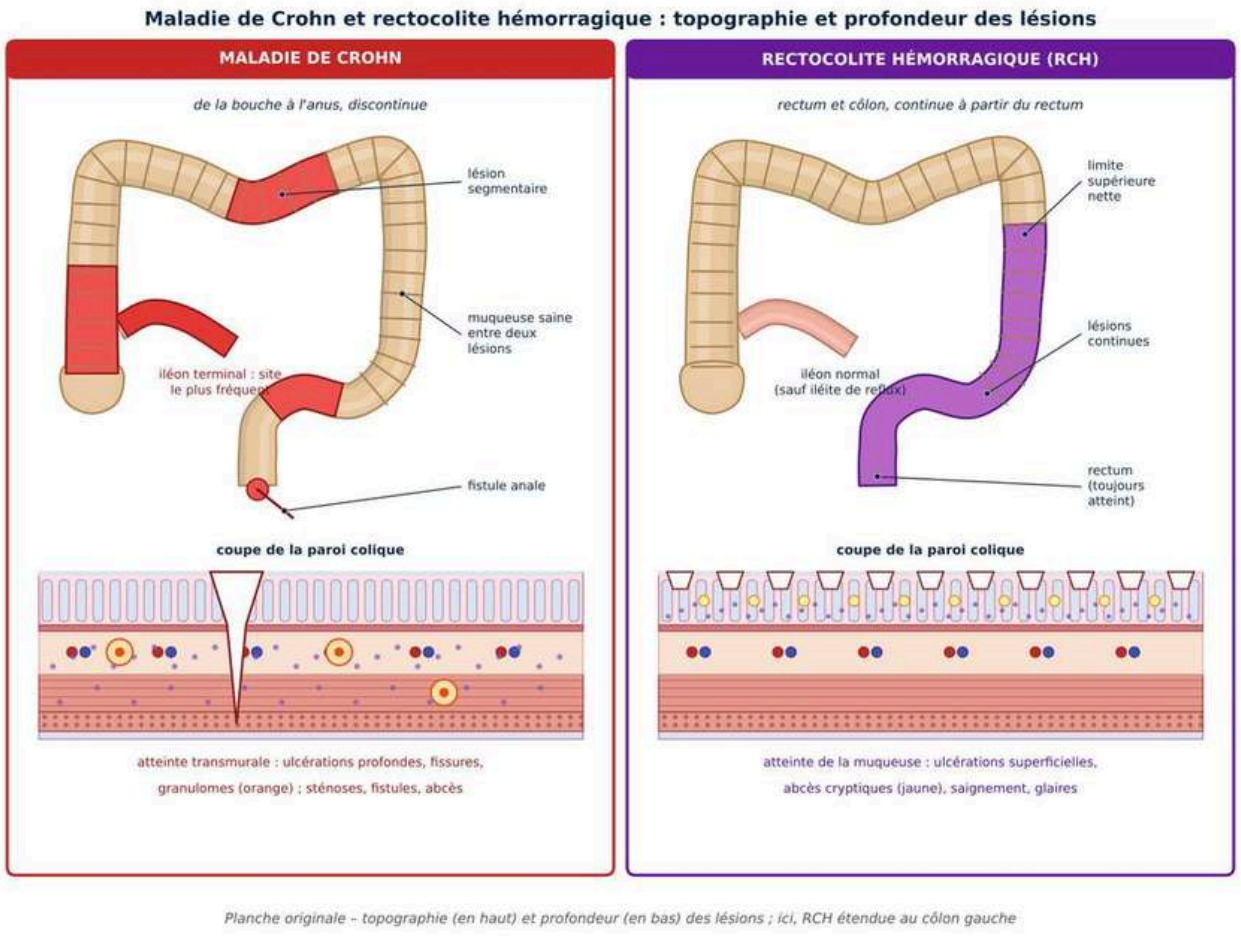


Planche originale – topographie (en haut) et profondeur (en bas) des lésions ; ici, RCH étendue au côlon gauche

Figure 32.12 – Maladie de Crohn et rectocolite hémorragique : topographie (en haut) et profondeur (en bas) des lésions (32.3.3)

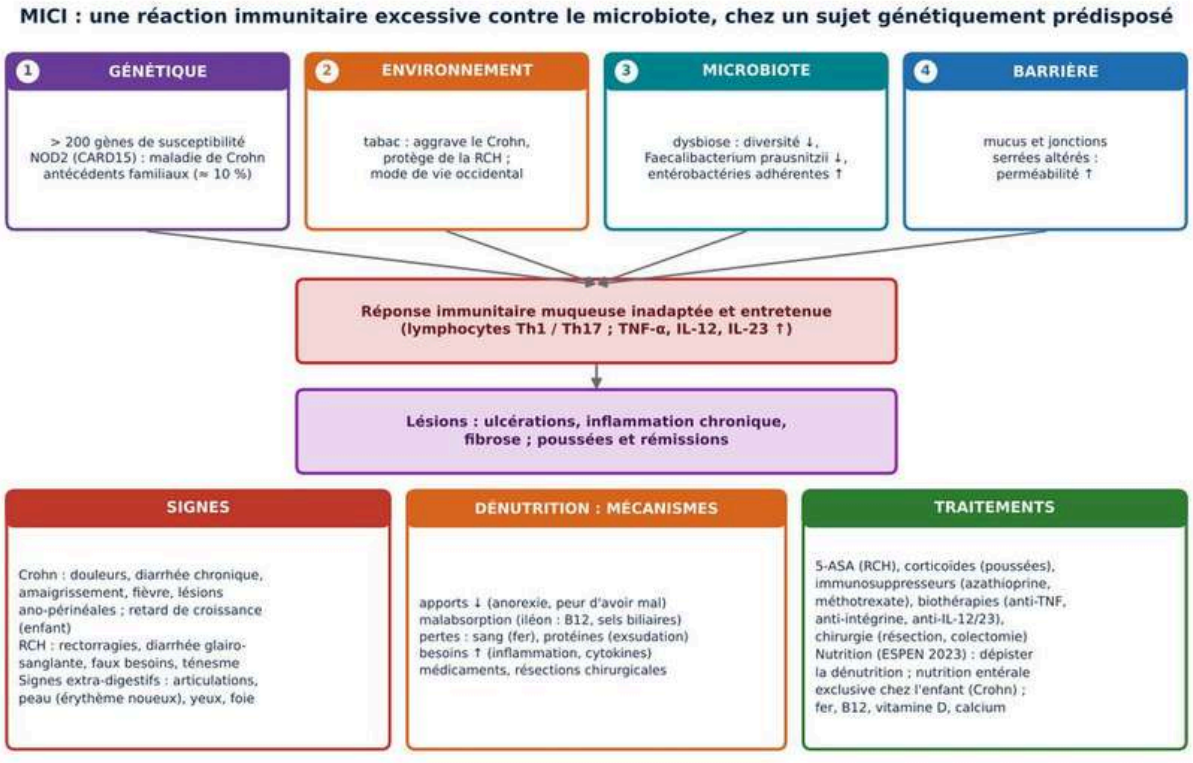


Figure 32.13 – MICI : une réaction immunitaire excessive contre le microbiote chez un sujet génétiquement prédisposé ; signes, mécanismes de la dénutrition et traitements (32.3.3)



Figure 32.14 – Le syndrome de l'intestin irritable : critères de Rome IV, mécanismes intriqués, sous-types et prise en charge (32.3.3)

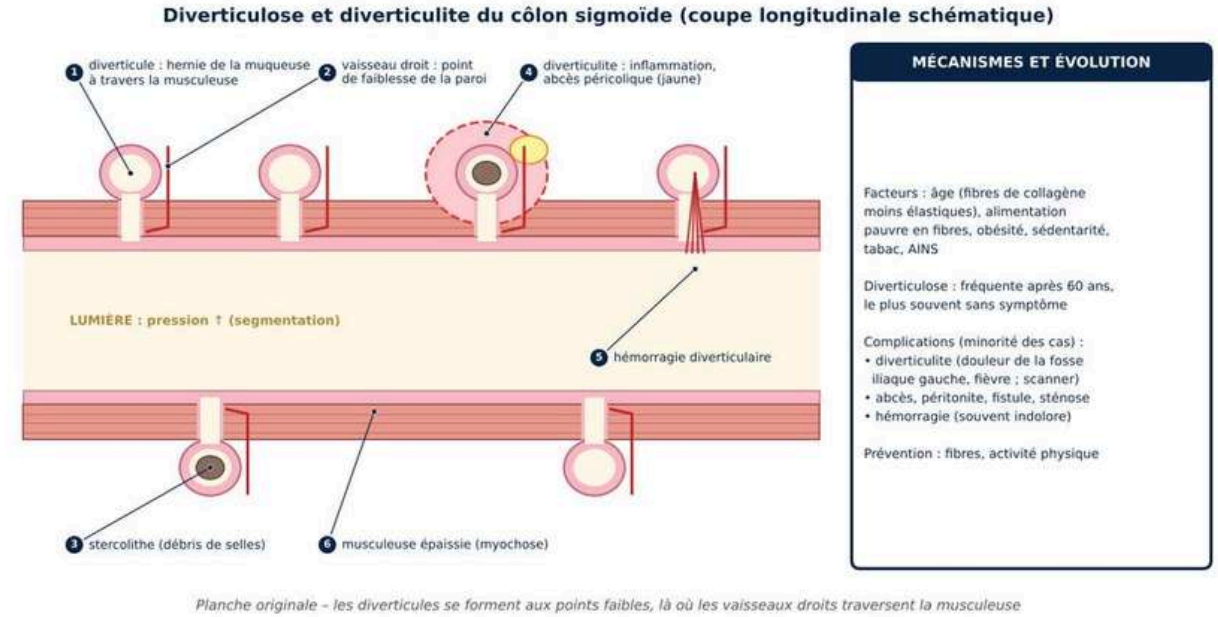


Figure 32.15 – Diverticulose et diverticulite du côlon sigmoïde (coupe longitudinale schématique) (32.3.3)



Figure 32.16 – Cancers du tube digestif : facteurs de risque, dépistage du cancer colorectal et conséquences nutritionnelles (32.3.4)

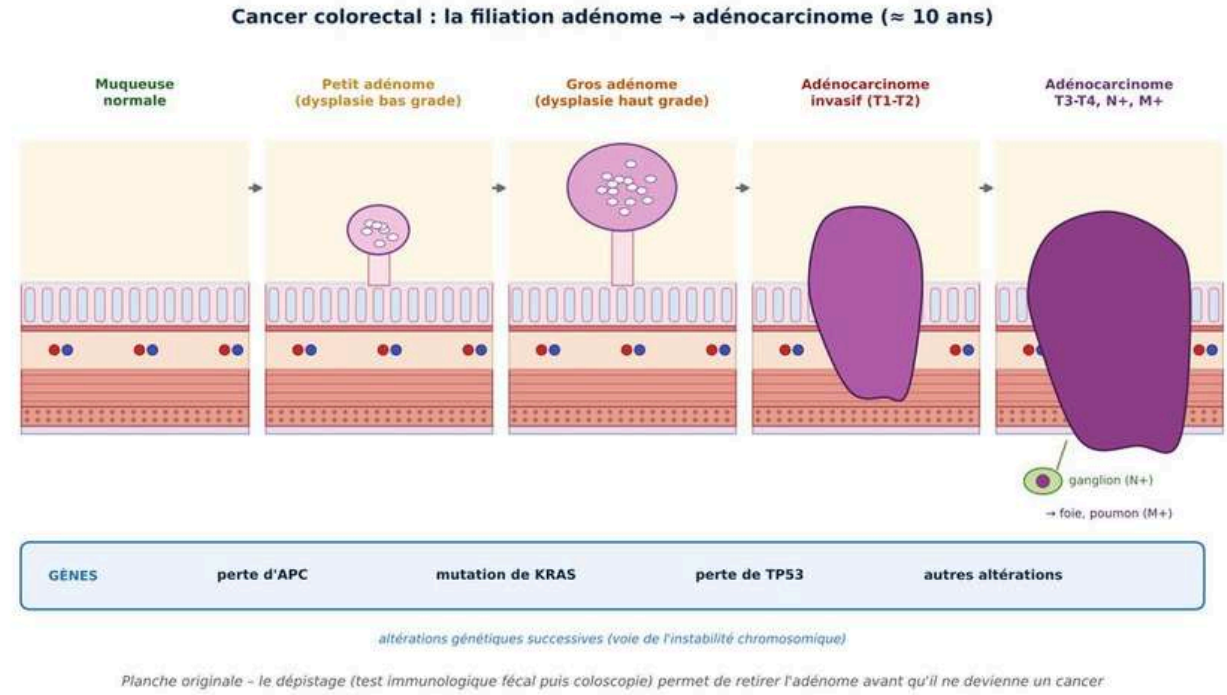


Figure 32.17 – Cancer colorectal : la filiation adénome → adénocarcinome, qui dure en moyenne une dizaine d'années (32.3.4)

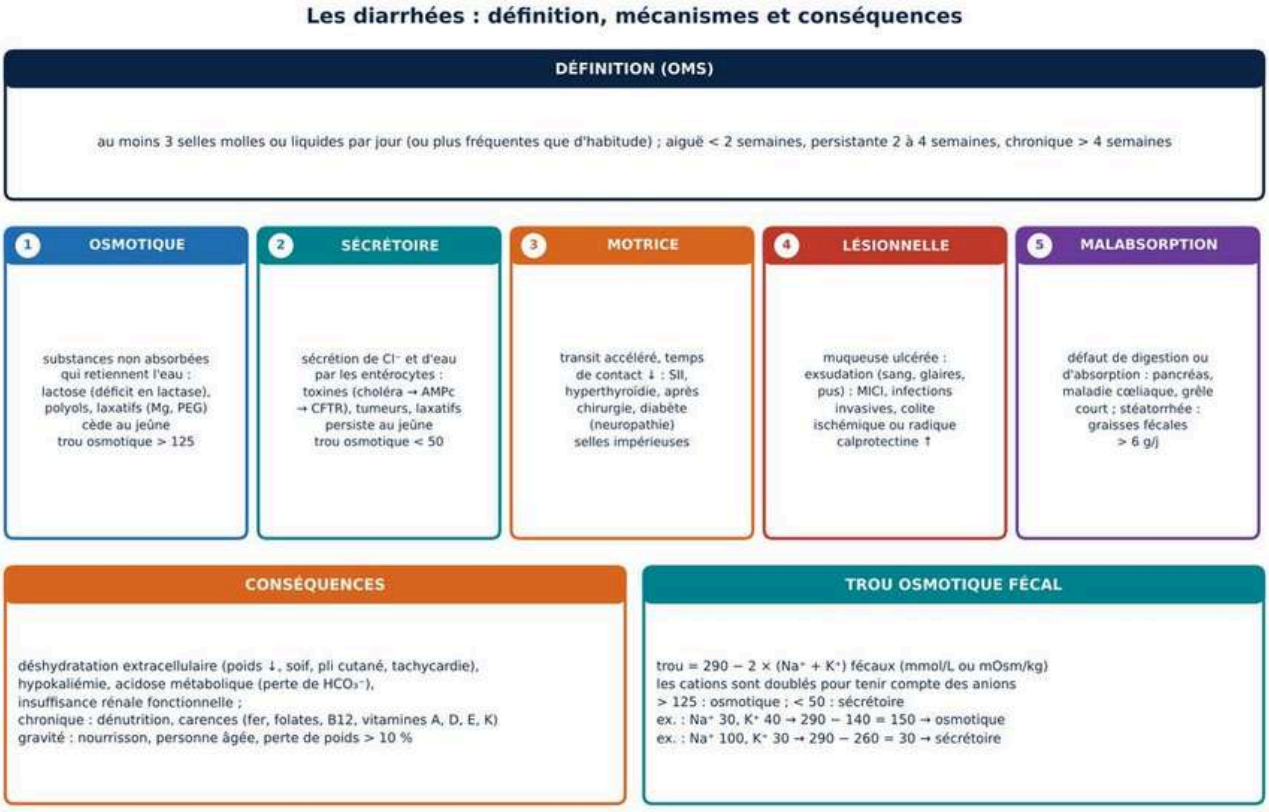


Figure 32.18 – Les diarrhées : définition, cinq mécanismes, conséquences et trou osmotique fécal (32.3.5)

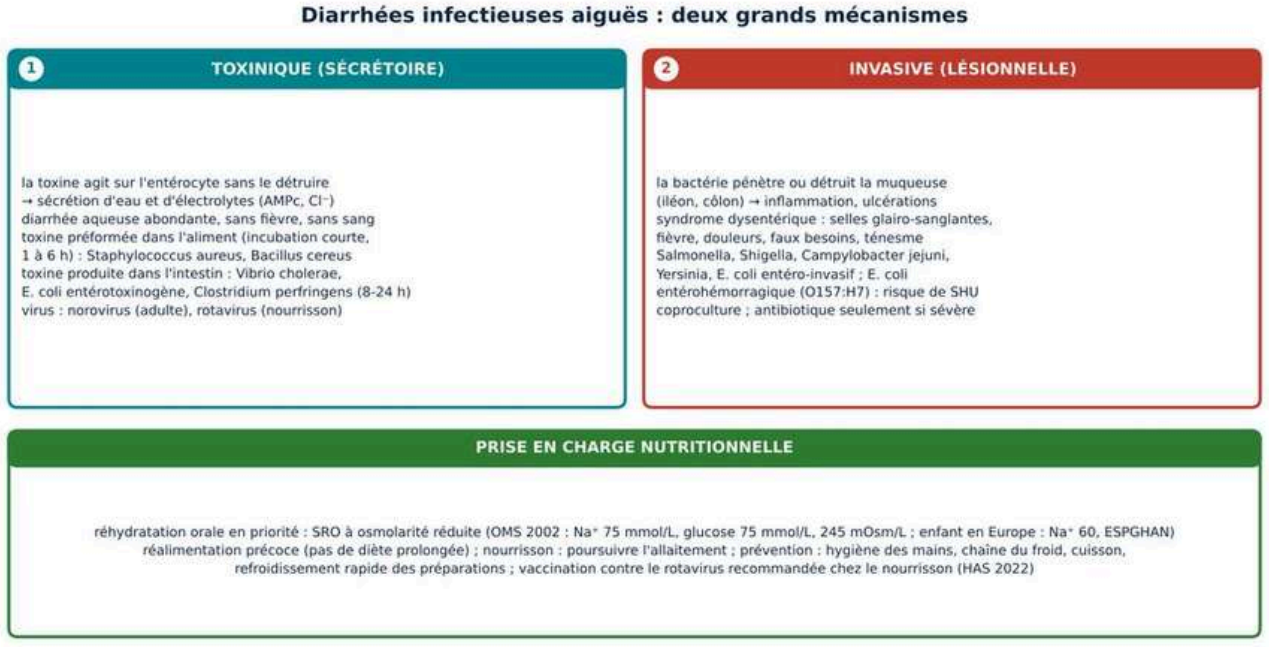


Figure 32.19 – Diarrhées infectieuses aiguës : mécanisme toxinique (sécrétoire) ou invasif (lésionnel), et prise en charge nutritionnelle (32.3.5)



Figure 32.20 – La constipation : définition, mécanismes (transit lent, trouble de l'évacuation), causes, signes d'alarme et prise en charge (32.3.5)

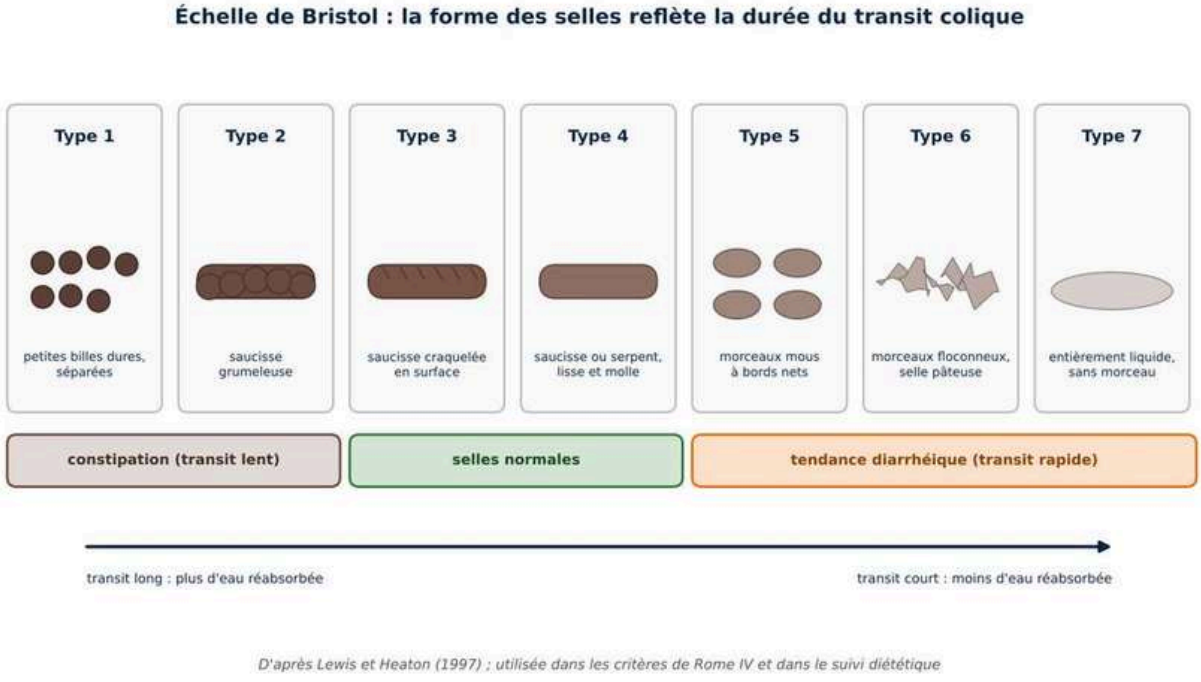


Figure 32.21 – L'échelle de Bristol : la forme des selles reflète la durée du transit colique (32.3.5)

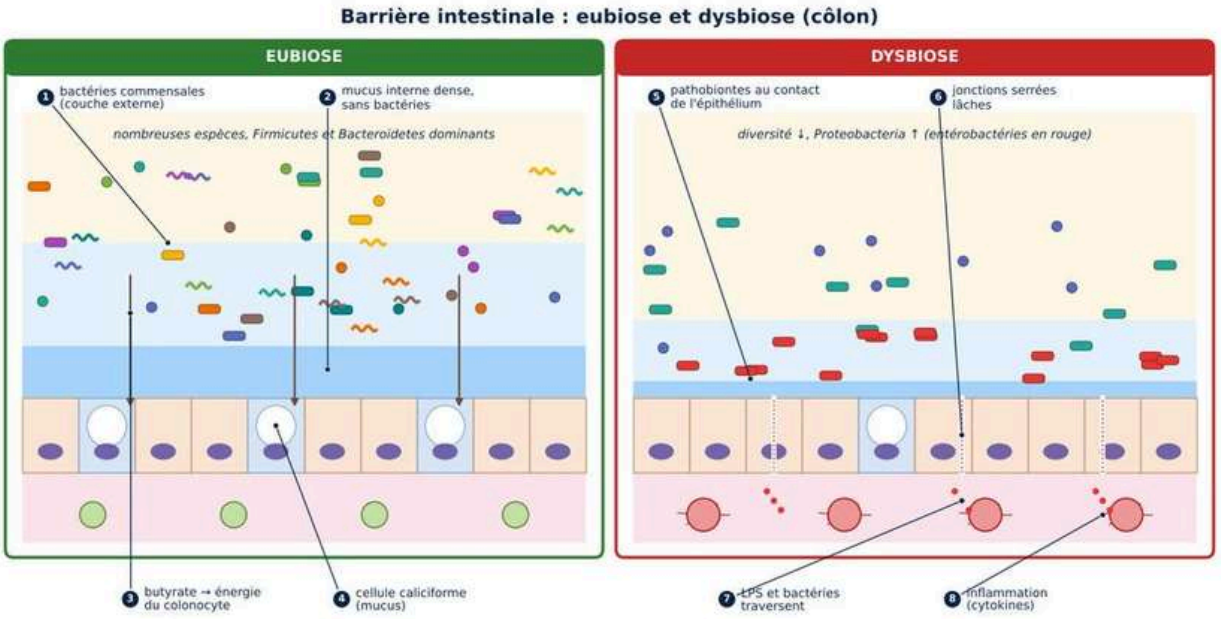
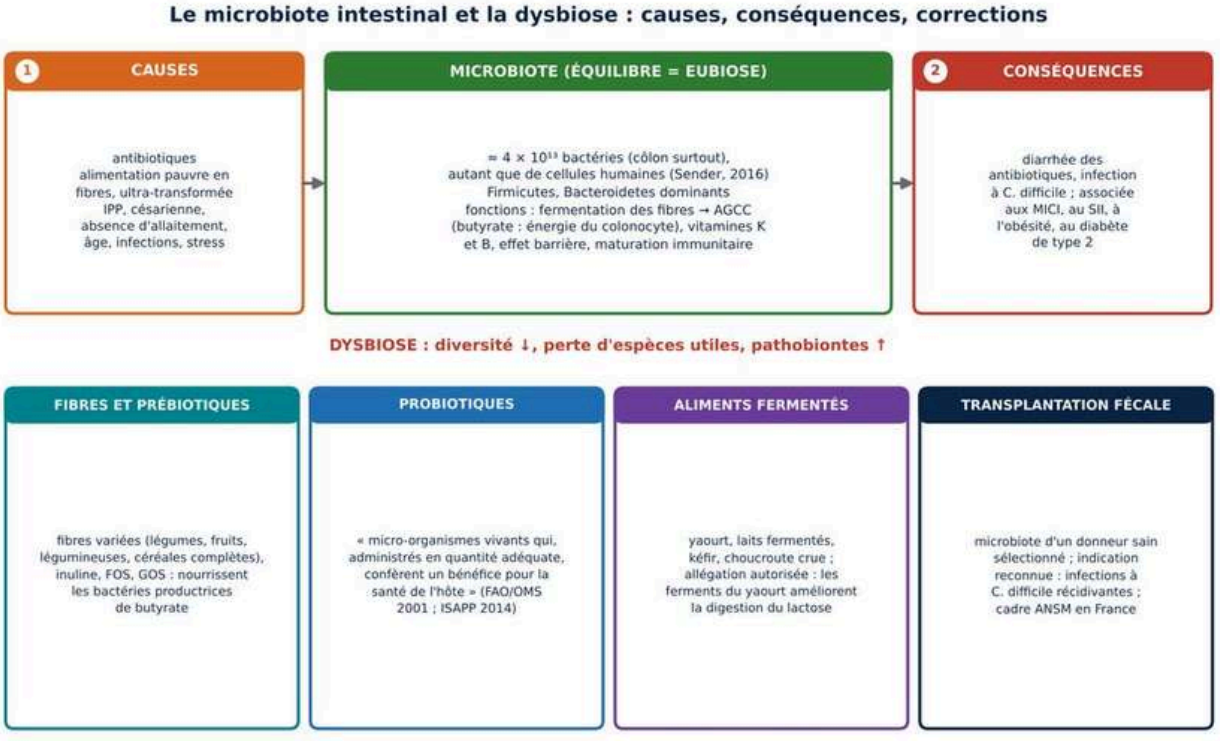


Planche originale – la dysbiose amincit le mucus, ouvre la barrière et active le système immunitaire de la muqueuse

Figure 32.22 – Barrière intestinale du côlon : eubiose (à gauche) et dysbiose (à droite) (32.3.6)



AGCC : acides gras à chaîne courte (acétate, propionate, butyrate) ; FOS : fructo-oligosaccharides ; GOS : galacto-oligosaccharides

Figure 32.23 – Le microbiote intestinal et la dysbiose : causes, fonctions de l'eubiose, conséquences et moyens de correction (32.3.6)

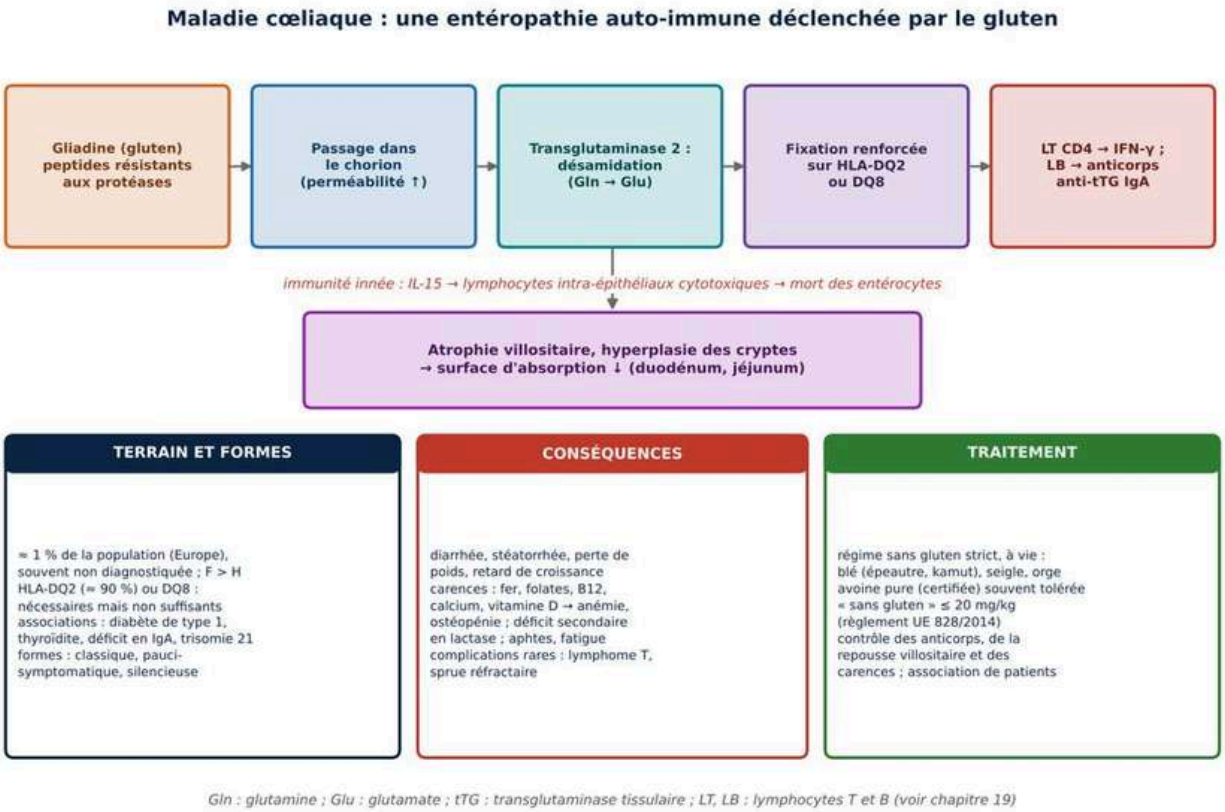


Figure 32.24 – Maladie cœliaque : une entéropathie auto-immune déclenchée par le gluten ; terrain, conséquences et traitement (32.3.7)

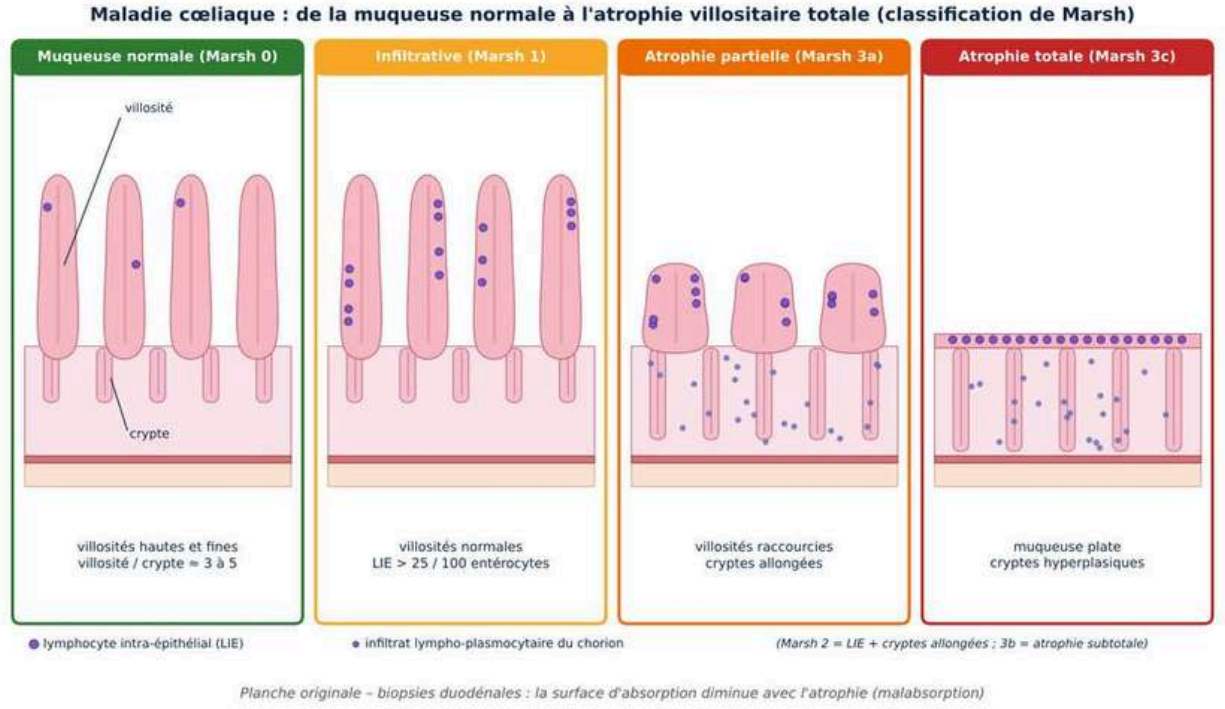
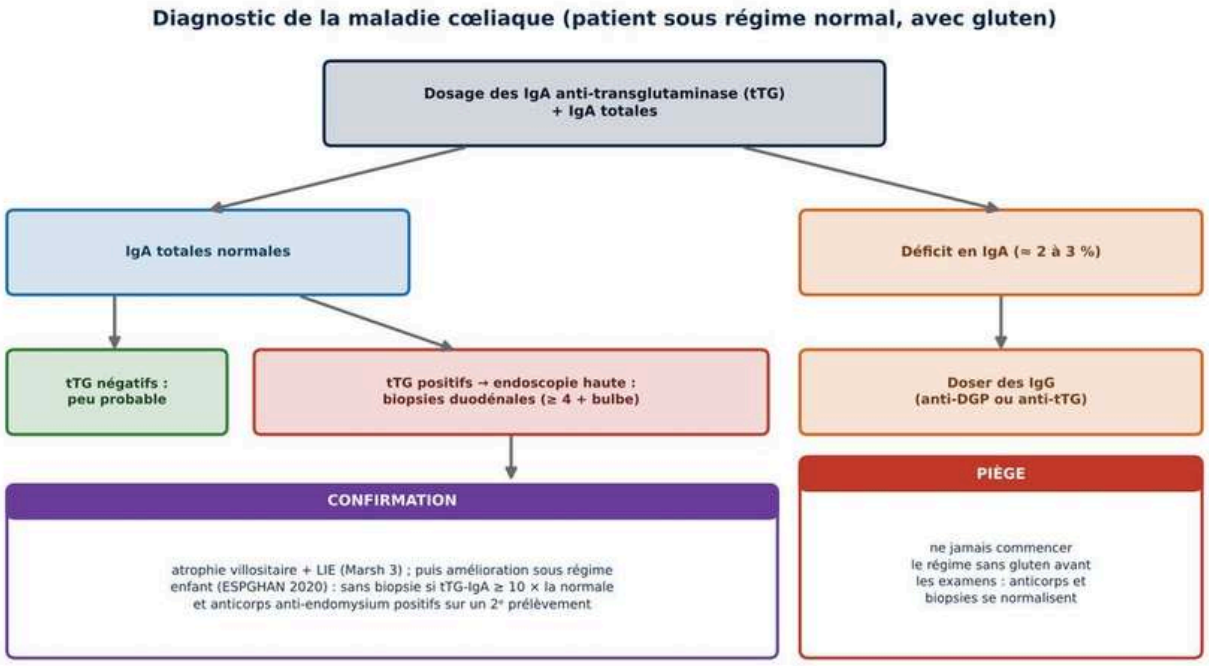


Figure 32.25 – Maladie cœliaque : de la muqueuse normale à l'atrophie villositaire totale (classification de Marsh, biopsies duodénales) (32.3.7)



DGP : peptides de gliadine désamidés ; LIE : lymphocytes intra-épithéliaux ; HLA-DQ2/DQ8 absents : diagnostic quasi exclu

Figure 32.26 – Diagnostic de la maladie cœliaque chez un patient sous régime normal, avec gluten (32.3.7)

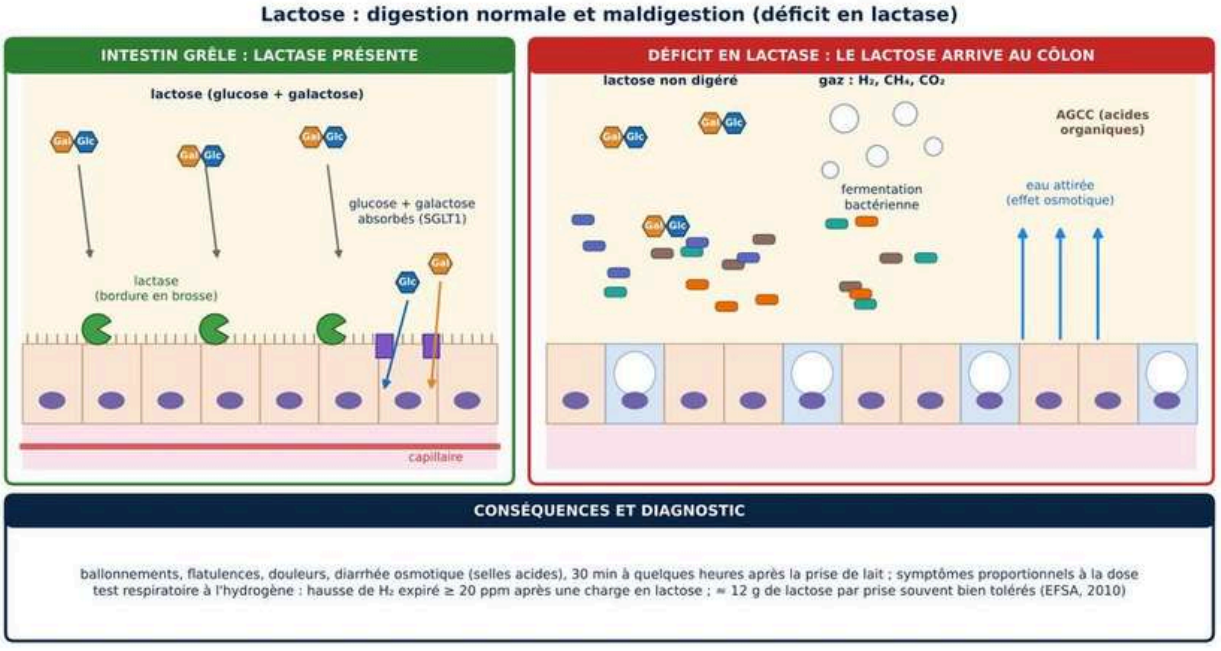
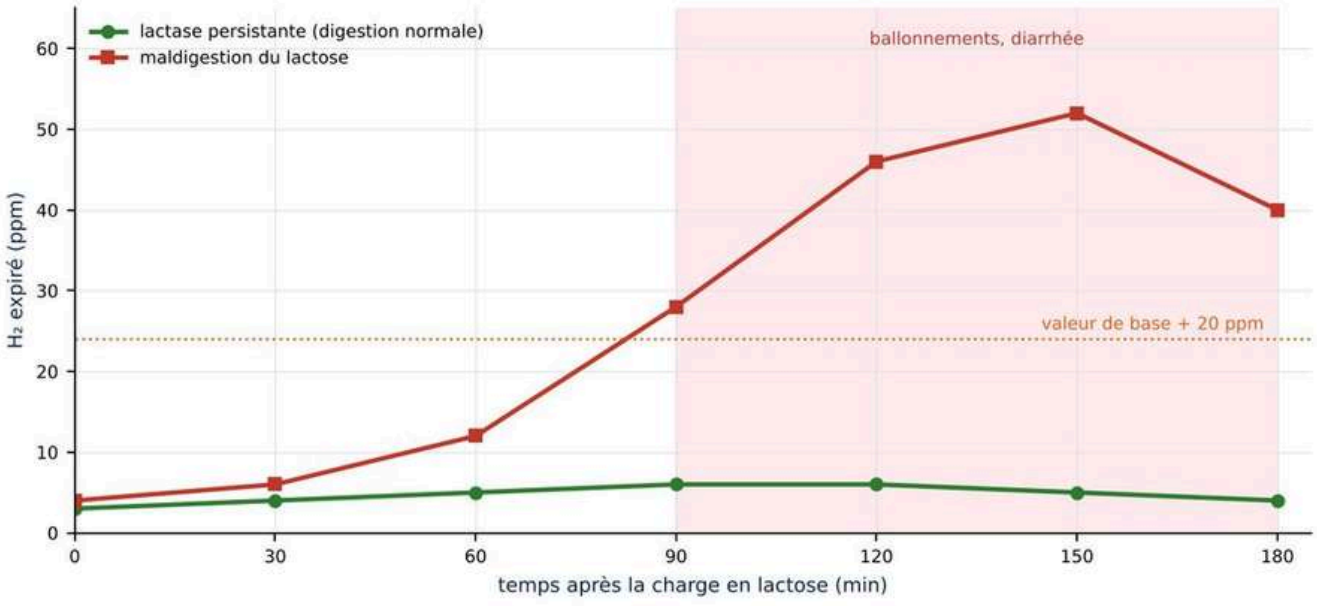


Planche originale – AGCC : acides gras à chaîne courte ; Glc : glucose ; Gal : galactose ; SGLT1 : cotransporteur sodium-glucose

Figure 32.27 – Lactose : digestion normale dans le grêle (à gauche) et maldigestion en cas de déficit en lactase (à droite) (32.3.8)



Test respiratoire à l'hydrogène (charge de 25 g de lactose, valeurs d'un cas) : positif si H_2 augmente d'au moins 20 ppm

Figure 32.28 – Test respiratoire à l'hydrogène après une charge de 25 g de lactose : lactase persistante et maldigestion (32.3.8)

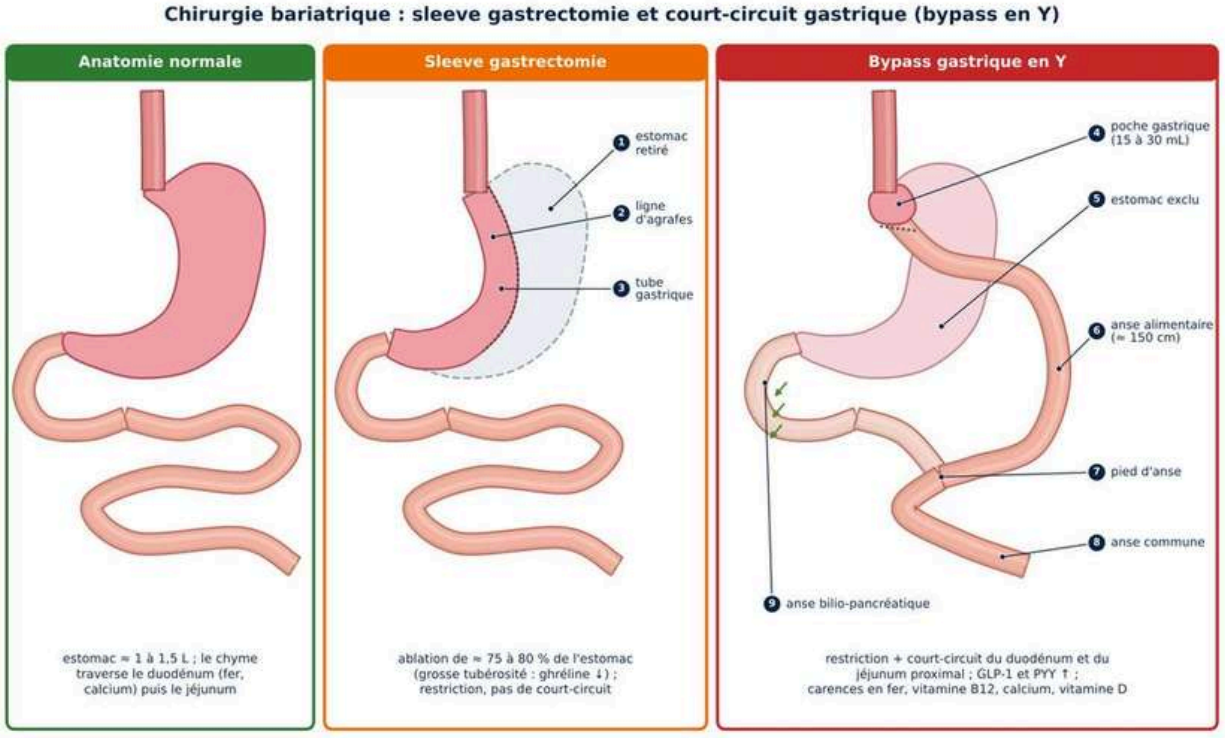


Planche originale – les deux interventions les plus pratiquées en France ; en vert, la bile et le suc pancréatique

Figure 32.29 – Chirurgie bariatrique : anatomie normale, sleeve gastrectomie et court-circuit gastrique (bypass en Y) (32.3.9)

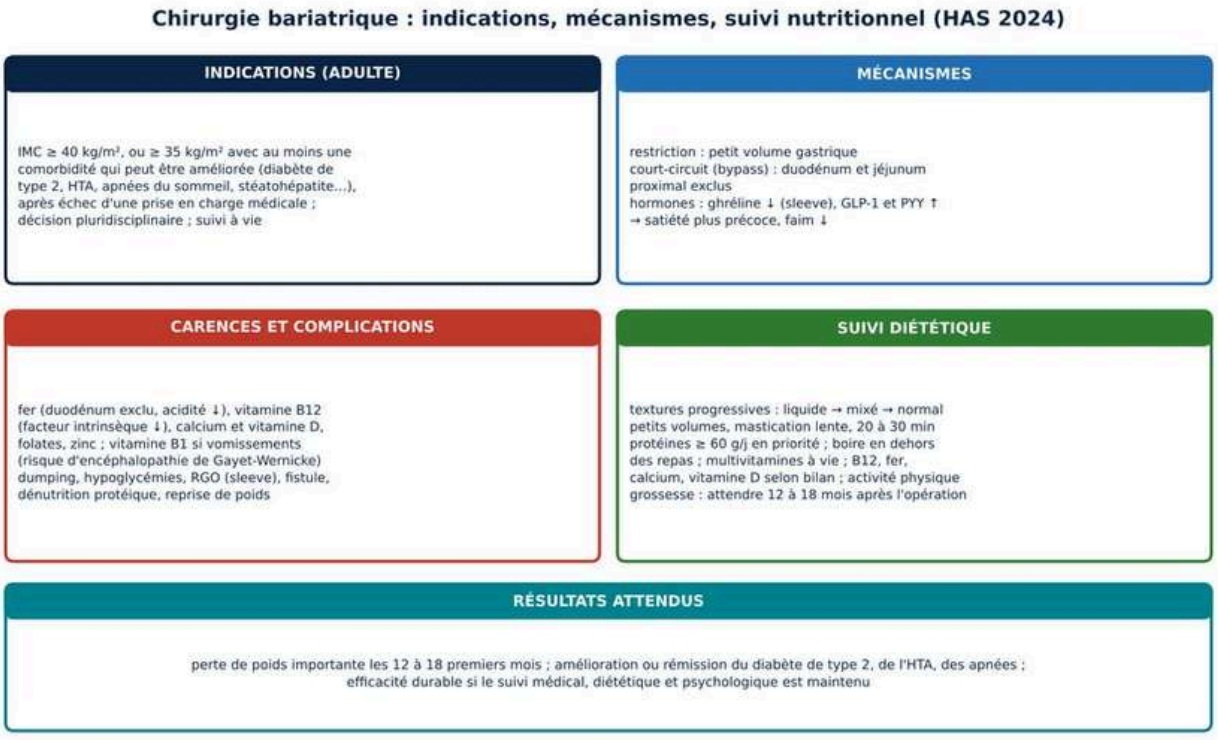


Figure 32.30 – Chirurgie bariatrique : indications, mécanismes, carences et complications, suivi diététique et résultats attendus (HAS 2024) (32.3.9)

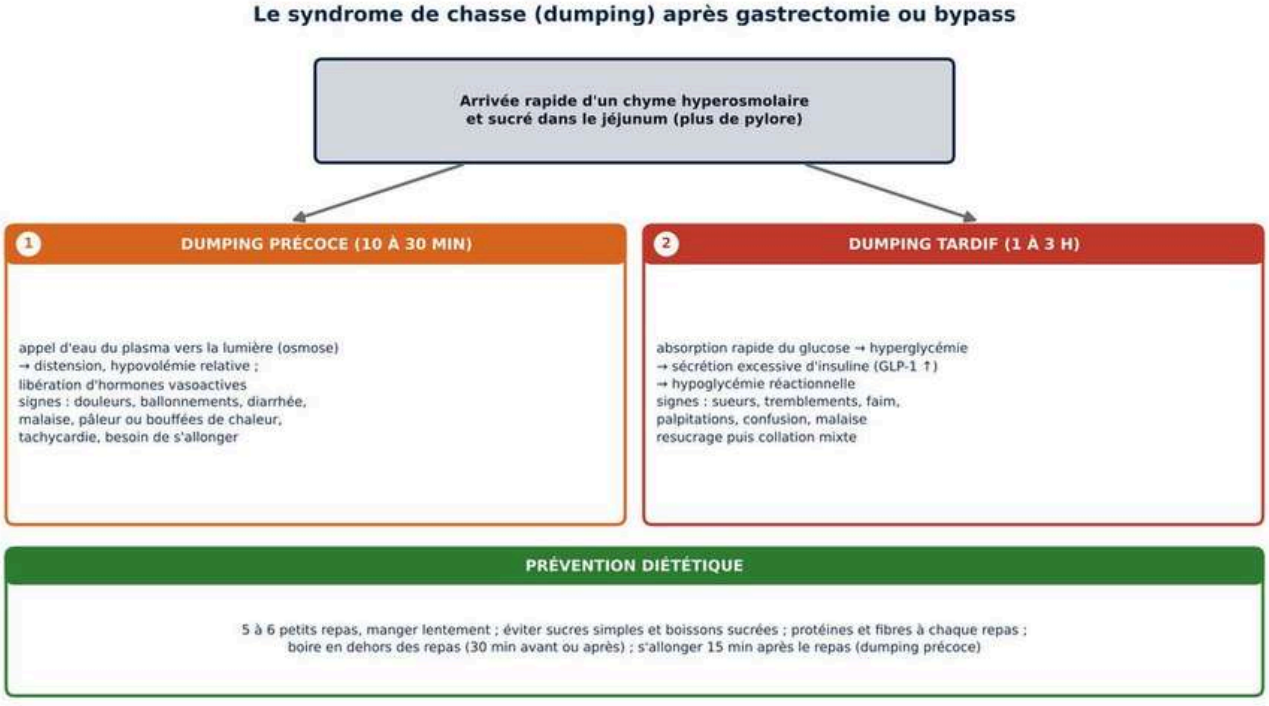
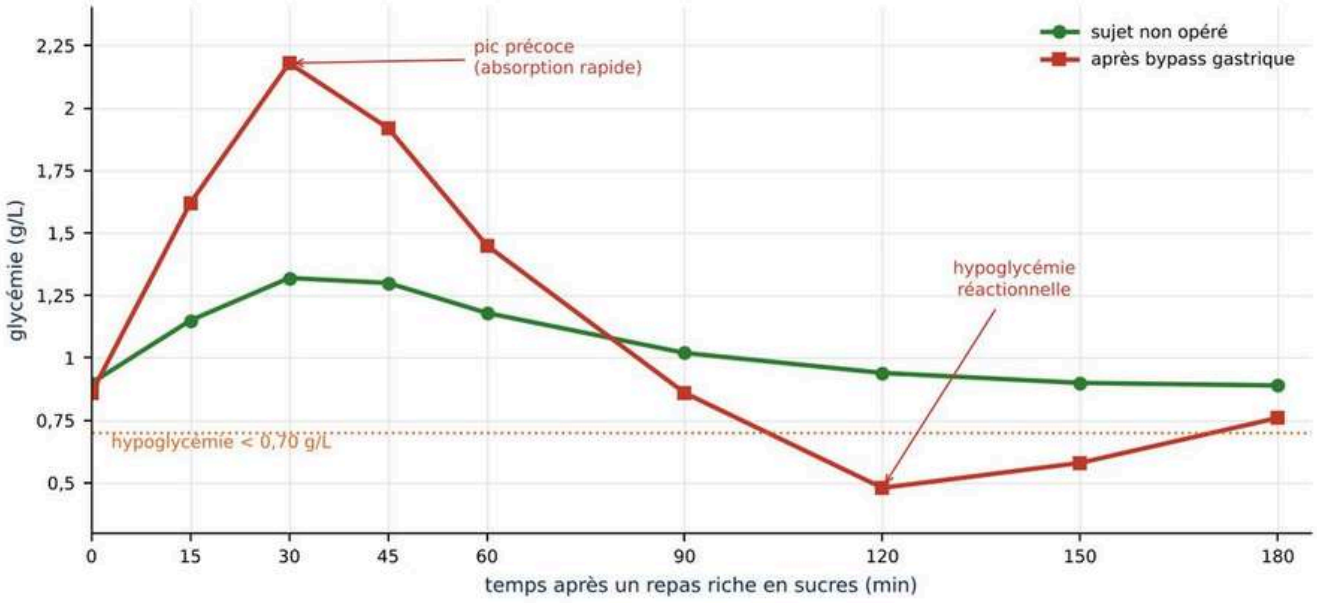


Figure 32.31 – Le syndrome de chasse (dumping) après gastrectomie ou bypass : dumping précoce, dumping tardif et prévention diététique (32.3.9)



Valeurs d'un cas : dumping tardif = hypoglycémie 1 à 3 h après le repas, par excès d'insuline (rôle du GLP-1)

Figure 32.32 – Glycémie après un repas riche en sucres chez un sujet non opéré et chez un patient opéré d'un bypass gastrique (32.3.9)

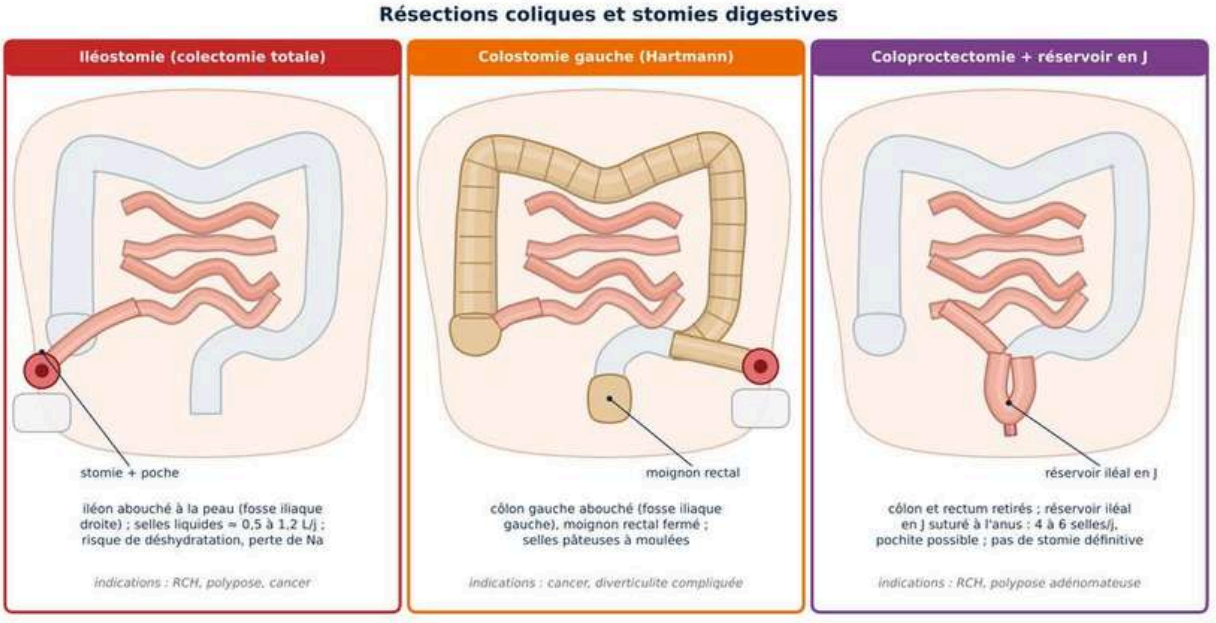


Planche originale - en gris, les segments retirés ; les stomies sont appareillées par une poche (vue de face, droite du sujet à gauche)

Figure 32.33 – Résections coliques et stomies digestives : iléostomie, colostomie gauche (Hartmann), coloproctectomie avec réservoir en J (32.3.9)

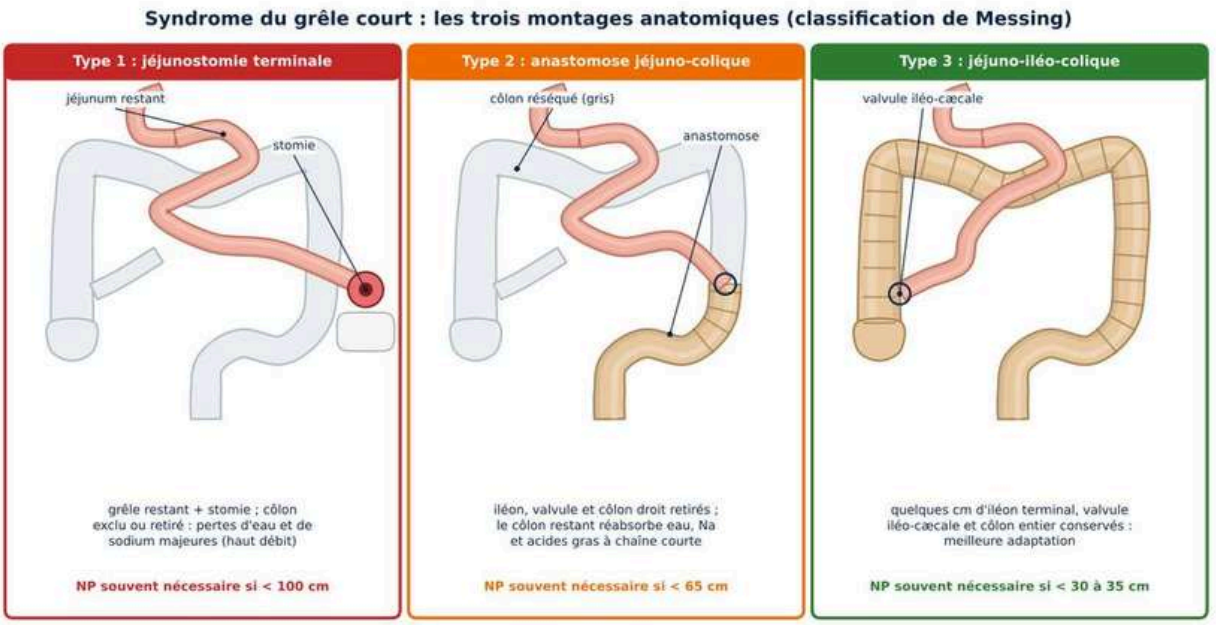
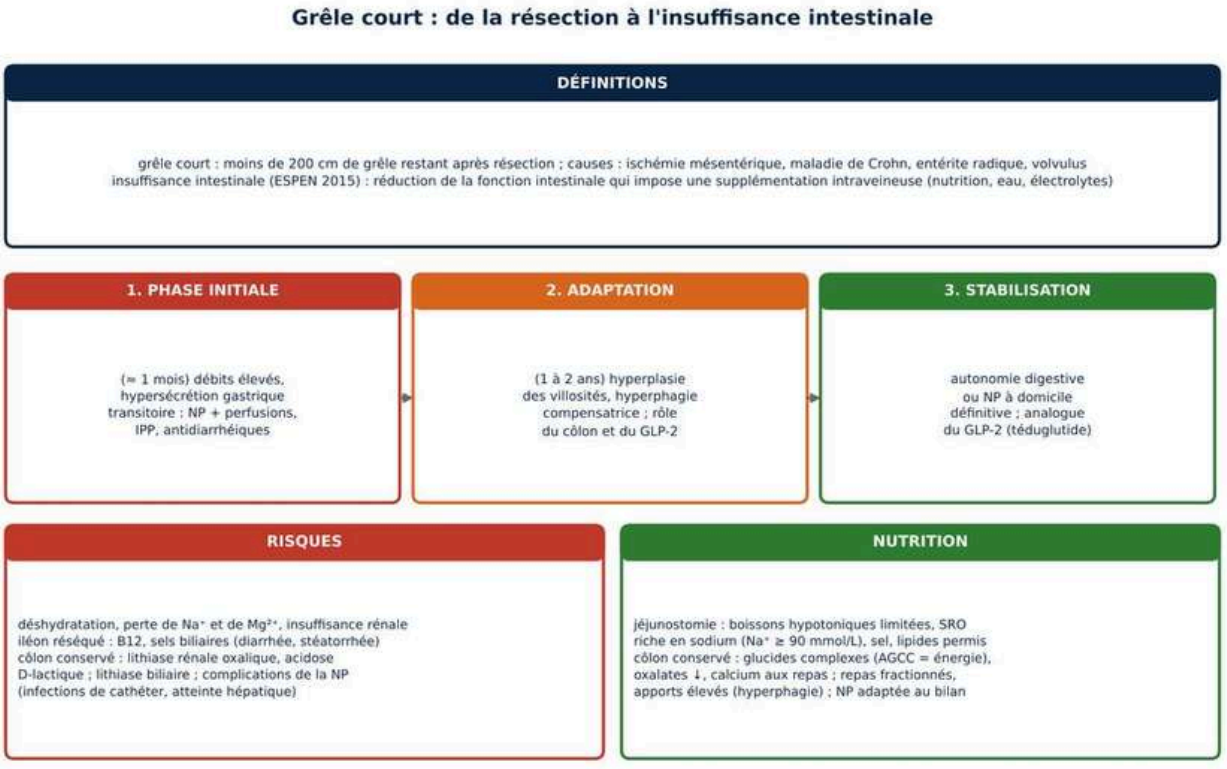


Planche originale – grêle court : moins de 200 cm de grêle restant ; seuils de dépendance à la nutrition parentérale (NP) d'après Messing (1999)

Figure 32.34 – Syndrome du grêle court : les trois montages anatomiques (classification de Messing) et les seuils de dépendance à la nutrition parentérale (32.3.9)



NP : nutrition parentérale ; SRO : soluté de réhydratation orale ; AGCC : acides gras à chaîne courte ; voir chapitre 17 pour l'absorption

Figure 32.35 – Grêle court : de la résection à l'insuffisance intestinale ; les trois phases, les risques et la nutrition (32.3.9)

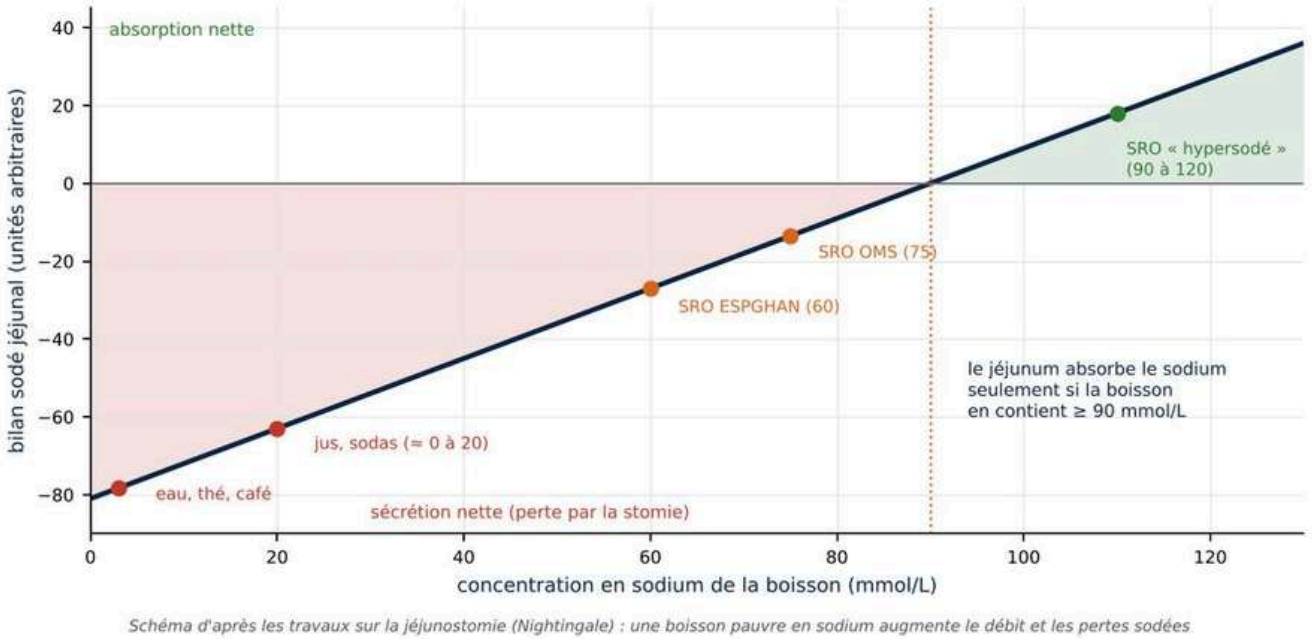


Schéma d'après les travaux sur la jéjunostomie (Nightingale) : une boisson pauvre en sodium augmente le débit et les pertes sodées

Figure 32.36 – Bilan sodé jéjunal selon la concentration en sodium de la boisson : le jéjunum n'absorbe le sodium que si la boisson en contient au moins 90 mmol/L (32.3.9)